

Çocuklarda Ülseratif Kolit — Tanı ve Tedavi Algoritması

Porto ölçütleriyle tanı, **PUCAI** ile şiddet sınıflaması ve ECCO/ESPGHAN temelli basamaklı tıbbi tedavi; akut ağır kolitin ivedi yönetimi vurgulanır.

Porto ölçütleri

PUCAI şiddet skoru

ECCO / ESPGHAN 2018

İnflamatuar bağırsak hastalığı

01 Tanı ve değerlendirme

Kronik (≥ 4 hafta) veya tekrarlayan **kanlı ishal**, karın ağrısı, tenesmus, aciliyet; sistemik bulgular ve büyüme geriliği olabilir. Tanı **Porto ölçütlerine** göre konur.

Tanı süreci (Porto)

- Öncelikle **enfeksiyonu dışla** (dışkı kültürü, **C. difficile**, parazit).
- İleokolonoskopi + üst GİS endoskopisi**, çok sayıda segmentten biyopsi.
- Crohn'u dışlamak için **ince bağırsak görüntülemesi** (MR enterografi).
- ÜK: rektumdan başlayan, sürekli, yüzeyel mukozal inflamasyon (kolona sınırlı).

Başlangıç tetkikleri

- Kan:** TKS, CRP/ESR, albümin, karaciğer/böbrek, demir.
- Dışkı:** kalprotektin, kültür + C. difficile toksini.
- Tedavi öncesi: TPMT/tiyopürin metaboliti, hepatit B, TB (biyolojik öncesi), aşı durumu.
- Büyüme, beslenme, kemik sağlığı ve psikososyal değerlendirme.

PUCAI (Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index) 0–85 puan; tedavi kararı ve yanıt izlemi bu skora dayanır.

Remisyon

< 10

Hastalık aktif değil;
idame hedefi.

Hafif

10–34

Ayaktan; 5-ASA ile
indüksiyon.

Orta

35–64

Oral steroid /
yükseltme
gerekebilir.

Ağır

≥ Akut ağır

65

kolit —
hastaneye
yatış.

PUCAI bileşenleri (özet)

PARAMETRE	ARALIK	PUAN
Karın ağrısı	Yok / hafif / şiddetli	0–10
Rektal kanama	Yok → çoğunlukla kan	0–30
Dışkı kıvamı	Şekilli → tümü sulu	0–10
Gün içi dışkı sayısı	0–2 → >8	0–15
Gece dışkılama (uykudan uyandıran)	Yok / var	0–10
Aktivite düzeyi	Kısıtsız → kısıtlı	0–10

Tanıyı doğrula → PUCAI ile şiddeti belirle → şiddete göre indüksiyon → yanıtı PUCAI ile izle → yanıtızlıkta yükselt; hedef **steroidsiz remisyon ve mukozal iyileşme**.

BAŞLANGIÇ

Tanı doğrulandı → PUCAI hesapla

Enfeksiyon (özellikle *C. difficile*) dışlandı. Hastalık yaygınlığı ve şiddeti belirlendi.

KARAR 1

PUCAI $\geq$ 65 (akut ağır kolit) mi?

EVET → hastaneye yatış

HAYIR → şiddete göre

AKUT AĞIR KOLİT

IV kortikosteroid + yakın izlem

Yatır; IV metilprednizolon. *C. difficile*'yi tekrar dışla. **3. ve 5. günde PUCAI** ile yanıtı değerlendir.

AYAKTAN

Hafif-orta indüksiyon

PUCAI 10–64: 5-ASA temelli indüksiyona başla.

ADIM 1 · HAFİF-ORTA İNDÜKSİYON

Oral + topikal 5-ASA (mesalazin)

Oral 5-ASA + proktit/sol kolonda **topikal 5-ASA** (lavman/supozituar). 2–4 haftada PUCAI ile yanıtı değerlendir.

KARAR 2

5-ASA ile yeterli yanıt var mı?

EVET → idame

HAYIR → yükselt

İDAME

5-ASA idamesini sürdür

Steroidsiz remisyonu koru; kalprotektin ve büyüme ile izle.

ADIM 2

Oral kortikosteroid ile indüksiyon

Oral prednizolon (veya uygun olgularda budesonid-MMX). Steroid **idame tedavisi değildir** — kademeli azalt.

KARAR 3

Steroide bağımlı / dirençli mi?

EVET → biyolojik / immünmodülatör

HAYIR → idame

ADIM 3 · YÜKSELTME

Anti-TNF (infliksimab) ± tiyopürin

Steroid bağımlı/dirençli hastalıkta **anti-TNF** başlat; idamede tiyopürin veya anti-TNF sürdür. Yanıtsızlıkta ikinci biyolojik (vedolizumab vb.).

İDAME

Steroidsiz remisyonu sürdür

5-ASA ± tiyopürin ile idame; düzenli izlem.

AKUT AĞIR KOLİT YOLU · 3.-5. GÜN

IV steroide yanıtsızsa ikinci basamak

PUCAI 3. günde >45 ise ikinci basamağı planla; 5. günde >65 ise başlat: **infliksimab** veya kalsinörin inhibitörü (siklosporin/takrolimus). Yanıt yoksa **kolektomi**.

Dozlar pediatrik kaynaklara göre yaklaşık olup çocuğun kilosu, yanıtı ve ilaç düzeyine göre bireyselleştirilir. Maksimumlar erişkin dozunu aşmaz.

İlaç dozları — indüksiyon ve idame		
İLAÇ	DOZ	NOT / İZLEM
Oral 5-ASA (mesalazin)	50–80 mg/kg/gün (maks 4–4.8 g/gün)	Hafif–orta indüksiyon + idame; böbrek fonksiyonu izlenir
Topikal 5-ASA	Lavman 25 mg/kg (≤ 1 g) supozituar 500 mg–1 g	Proktit/sol kolon; oral ile birlikte etkinliği artırır
Oral prednizolon	1 mg/kg/gün (maks 40 mg)	İndüksiyon; ~8–10 haftada azaltılır. İdamede kullanılmaz
IV metilprednizolon	1–1.5 mg/kg/gün (maks 40–60 mg)	Akut ağır kolit; 3.–5. gün PUCAI ile yanıt
Azatiyoprin	2–2.5 mg/kg/gün	İdame; TPMT önce , TKS+KCFT izlemi, metabolit düzeyi
6-merkaptopurin	1–1.5 mg/kg/gün	Azatiyoprin alternatifi
İnfliksimab	5 mg/kg · 0-2-6. hafta sonra 8 haftada bir	Ağır/dirençli olguda dozu yükselt veya aralığı kısalt; trough düzeyi ile optimize
Adalimumab	Kiloya göre yükleme sonra 2 haftada bir s.c.	Anti-TNF alternatifi
Kalsinörin inhibitörü	Siklosporin 2 mg/kg/gün IV veya takrolimus	IV steroide dirençli akut ağır kolitte köprü; düzey izlemi
İkinci sıra biyolojik	Vedolizumab / ustekinumab	Anti-TNF yanıtı/kayıplı olgularda

Şiddete göre strateji		
DURUM	İNDÜKSİYON	İDAME
Hafif–orta	Oral + topikal 5-ASA	5-ASA

DURUM	İNDÜKSİYON	İDAME
5-ASA yetersiz	Oral kortikosteroid (± budesonid-MMX)	5-ASA ± tiyopürin
Steroid bağımlı/dirençli	Anti-TNF	Anti-TNF ± tiyopürin
Akut ağır kolit (PUCAI ≥ 65)	Yatış + IV steroid	Yanıtı göre biyolojik
IV steroide dirençli	İnfliksimab veya kalsinörin inhibitörü	Anti-TNF / tiyopürin
Tıbbi tedaviye dirençli	Kolektomi	

Tedavi hedefi (treat-to-target): klinik remisyon değil, **steroidsiz remisyon + mukozal/biyokimyasal iyileşme** — normalize kalprotektin ve endoskopik iyileşme. Steroidler yalnızca indüksiyon içindir.

Aktivite (PUCAI) + biyobelirteç (kalprotektin) + gerektiğinde endoskopi ile "treat-to-target"; ilaca özgü güvenlik izlemi ayrıca yürütülür.

Ne, ne zaman izlenir		
İZLEM	SIKLIK	HEDEF / EŞİK
PUCAI (klinik)	Her ziyaret / alevlenmede	< 10 (remisyon)
Fekal kalprotektin	~3 ayda bir, ataktan sonra	Normalizasyon (<100–250 µg/g)
TKS, CRP, albümin, KCFT	3 ayda bir (tiyopürinde daha sık)	Normal; sitopeni/hepatotoksisite izle
Endoskopik yeniden değerlendirme	Hedefe ulaşımı doğrulamak için	Mukozal iyileşme
Tiyopürin metaboliti	Başlangıç titrasyonu + gerektiğinde	6-TGN terapötik; başlamadan TPMT
Anti-TNF trough + antikor	İndüksiyon sonrası / yanıt kaybında	Terapötik düzey (TDM ile doz optimize)
Büyüme, puberte, D vit/kemik	Her ziyaret / yıllık DXA endikasyonla	Persentil korunumu
KRK süreyans kolonoskopisi	Yaygın kolitte tanıdan 8–10 yıl sonra, 1–2 yılda bir; PSC varsa tanıdan itibaren yıllık	Displazi taraması

Tedaviye başlarken güvenlik

- İmmüsupresyon öncesi **aşılarda tamamlama**; canlı aşı immüsupresyonda kontrendike.
- Biyolojik öncesi **latent TB (IGRA/PPD) ve HBV** taraması.
- Tiyopürin öncesi **TPMT**; kombinasyonda lenfoma/HSTCL riskini göz önünde tut.

Alevlenme / atak yönetimi

- Her alevlenmede **C. difficile** ve dirençli olguda **CMV koliti** (biyopsi) dışla.
- Ağır atakta **VTE profilaksisi** ve dehidratasyon/elektrolit yönetimi.
- Yanıt kaybında önce **ilaç düzeyi/uyumu**, sonra basamak yükseltme.

06 Kırmızı bayraklar / komplikasyonlar

• **PUCAI ≥ 65** — akut ağır kolit, yatış

• **Toksik megakolon** — distansiyon, sistemik toksisite

• Ağır kanama, ciddi anemi, transfüzyon ihtiyacı

• Perforasyon / peritonit bulguları

• Ağır hipoalbuminemi, hızlı kilo kaybı

• IV steroide 3–5 günde yanıtsızlık

• Süperenfeksiyon: **C. difficile** / CMV koliti

• < 6 yaş / atipik seyir → **monogenik IBD** (VEO-IBD) düşün

Kolektomi endikasyonları

- **Akut:** tıbbi tedaviye dirençli akut ağır kolit; toksik megakolon, perforasyon, kontrol edilemeyen kanama.
- **Elektif:** uygun tedaviye rağmen inatçı hastalık, steroide bağımlılık ve biyolojiklerin başarısızlığı.
- Displazi/malignite saptanması.
- Tercih edilen: **restoratif proktokolektomi + IPAA** (ileoanal poş); çok disiplinli (cerrah, stoma hemşiresi) planlama.

Basamak yükseltme tetikleyicileri

- IV steroide **3. günde PUCAI > 45** → ikinci basamağı planla; **5. günde > 65** → başlat.
- Anti-TNF **yanıt kaybı:** önce trough/antikor → doz optimize → ikinci biyolojiğe geç.
- Steroid bağımlılık: idamede biyolojik/immünmodülatöre geçiş.
- **VEO-IBD (< 6 yaş)** / atipik seyir: monogenik zemin için immünolojik-genetik değerlendirme.

Uyarı: Bu şema eğitim ve hızlı başvuru amaçlıdır; bireysel klinik karar, güncel kılavuzlar ve yerel protokollerin yerine geçmez. İlaç seçimi, dozları ve biyolojik tedavi kararları deneyimli pediatrik gastroenteroloji ekibince verilmelidir.

Kaynaklar

1. Turner D, Ruemmele FM, Orlanski-Meyer E, ve ark. Management of Paediatric Ulcerative Colitis, Part 1: Ambulatory Care — ECCO-ESPGHAN Guideline. *JPGN*. 2018;67(2):257–291.
2. Turner D, Ruemmele FM, Orlanski-Meyer E, ve ark. Management of Paediatric Ulcerative Colitis, Part 2: Acute Severe Colitis — ECCO-ESPGHAN Guideline. *JPGN*. 2018;67(2):292–310.
3. Levine A, Koletzko S, Turner D, ve ark. ESPGHAN Revised Porto Criteria for the Diagnosis of Inflammatory Bowel Disease in Children and Adolescents. *JPGN*. 2014;58(6):795–806.

4. Turner D, Otley AR, Mack D, ve ark. Development and Validation of the Pediatric Ulcerative Colitis Activity Index (PUCAI). *Gastroenterology*. 2007;133(2):423–432.